

Síndromes Exantemáticas - Avançada

Conceitos Fundamentais e Epidemiologia

A Doença de Kawasaki é uma **vasculite** que afeta principalmente os **vasos de médio calibre**, com predileção especial pelas **artérias coronárias**. Vale destacar que o diagnóstico é essencialmente clínico, não existe um exame laboratorial específico que feche o diagnóstico. A Kawasaki é a **segunda causa de vasculite mais comum na infância**, perdendo apenas para a púrpura de Henoch-Schönlein.

Quanto ao perfil epidemiológico, a maioria dos casos ocorre em **menores de cinco anos**, com pico de incidência entre **nove e doze meses de idade**. É mais frequente em crianças de **etnia asiática**, especialmente japoneses, e acomete mais **meninos** na proporção de 1,5 para 1. Aqui vai um ponto que gera confusão: apesar de toda a preocupação com essa doença, ela é geralmente **autolimitada** e resolve em cerca de 12 dias mesmo sem tratamento. Então por que tratamos? Porque as **complicações são devastadoras**. O grande fantasma da Kawasaki são os **aneurismas de coronárias**, que podem evoluir com disfunção miocárdica e infarto. Por isso é fundamental reconhecer e tratar precocemente.

Critérios Diagnósticos da Kawasaki Completa

Segundo a **American Heart Association**, para fechar o diagnóstico de Kawasaki completa você precisa de **febre prolongada por pelo menos quatro dias** associada a **quatro ou cinco dos seguintes critérios**. Um detalhe importante: esses critérios não precisam estar presentes todos ao mesmo tempo, basta que tenham ocorrido ao longo do curso clínico da doença.

O primeiro critério é o **exantema polimorfo**. Pode ser praticamente qualquer tipo de exantema, mas o mais comum é aquele que começa na **região perineal**, tem

aspecto **morbiliforme** e pode evoluir com descamação. Uma pegadinha clássica de prova: a **hiperemia e descamação da cicatriz de BCG** também conta como manifestação cutânea da Kawasaki. Fique atento a isso.

O segundo critério são as **alterações de lábios e cavidade oral**. Não é uma apresentação muito específica, mas geralmente você vai ver lábios vermelhos, ressecados e fissurados, além da famosa **língua em framboesa**, aquela com hipertrofia das papilas que lembra muito a língua da escarlatina. Importante: vesículas e úlceras na cavidade oral são achados que falam contra Kawasaki e sugerem outras etiologias, então cuidado para não confundir.

O terceiro critério é a **conjuntivite bilateral não purulenta**. A criança chega com os olhos vermelhos, mas sem aquela secreção amarelada ou esverdeada. Em até 70% dos casos pode haver comprometimento de úvea anterior, então fique esperto com crianças febris com manifestação ocular.

O quarto critério é a **linfadenopatia cervical**, geralmente **unilateral e assimétrica**, com pelo menos **um linfonodo maior que 1,5 centímetro**. Essa apresentação unilateral é bem característica e ajuda a diferenciar de outras causas de adenomegalia.

O quinto critério são as **alterações de extremidades ou região perineal**. Essa costuma ser a manifestação mais tardia. Na fase aguda você observa **edema endurecido com eritema difuso** em palmas e plantas. À medida que a doença evolui, surge a **descamação periungueal**, aquela que começa ao redor das unhas e vai progredindo para o restante da mão ou do pé. A descamação com descolamento abaixo da unha é um achado mais tardio e muito característico.

E aqui vai o sexto e talvez mais importante critério: a doença **não pode ser explicada por outra etiologia**. Isso é fundamental porque várias dessas manifestações podem se sobrepor a outras doenças exantemáticas ou infecciosas.

Kawasaki Incompleta: Quando Suspeitar e Como Investigar

Nem sempre a criança vai chegar com o quadro completo, e é aí que entra a **Kawasaki incompleta**. Você deve suspeitar quando há **febre persistente por cinco dias ou mais** associada a apenas **dois ou três critérios clínicos**. Para lactentes jovens, especialmente **menores de um ano**, uma febre **maior que sete dias** sem outra explicação já deve levantar suspeita.

Diante dessa suspeita, o próximo passo é avaliar os **critérios laboratoriais**. Começa-se pelas provas inflamatórias: **PCR maior que 30** ou **VHS maior que 40**, ou ainda **procalcitonina maior que 0,6**. Se as provas inflamatórias estiverem elevadas, você mantém a investigação e avalia os seguintes achados: **anemia normocítica normocrômica** para a idade, **plaquetas acima de 450.000**, **albumina menor ou igual a 3**, **elevação de TGP** geralmente menor que 50, **leucocitose acima de 15.000** e **piúria estéril**, ou seja, leucócitos na urina sem bactérias ou outros sinais de infecção.

O **ecocardiograma** entra como peça fundamental na investigação do Kawasaki incompleto. Você vai avaliar se há algum **aneurisma da coronária descendente anterior ou da coronária direita maior que 2,5 desvios-padrão**, evidências de acometimento miocárdico, regurgitação valvar ou efusão pericárdica.

Manejo Terapêutico: Estratificação de Risco e Tratamento

Antes de iniciar o tratamento, o primeiro passo é determinar se o paciente tem **risco de resistência à imunoglobulina**. Os principais fatores de risco são: **idade menor que seis meses** como marcador muito sensível para aneurisma coronariano, presença de **dilatação coronariana já na apresentação**, associação com **choque** ou **síndrome de ativação macrofágica**.

Para crianças de descendência japonesa, existe o **escore de Kobayashi**, que avalia idade, plaquetas, sódio, neutrofilia e tempo de apresentação da doença. Quanto maior o escore, maior o risco de resistência ao tratamento. Porém, esse critério não

foi bem validado em populações não japonesas, então para essas crianças você deve ficar atento principalmente aos outros achados clínicos.

O tratamento padrão consiste em **imunoglobulina intravenosa na dose de 2 gramas por quilo**, feita em infusão lenta, em dose única. O sucesso do tratamento é maior quando instituído nos **primeiros 7 a 10 dias de doença**. Mesmo pacientes com febre persistente superior a dez dias, mas que tenham aneurisma ou evidência de inflamação sistêmica importante, devem receber o tratamento.

Junto com a imunoglobulina, prescreve-se **AAS em dose alta, de 30 a 50 miligramas por quilo por dia**, divididos em quatro doses. Após a resolução da febre, reduz-se para **dose antiagregante de 3 a 5 miligramas por quilo por dia**.

Atenção às **contraindicações do AAS**: exposição ou infecção confirmada por **influenza** ou **varicela**, **plaquetopenia abaixo de 50.000**, **sangramento ativo** ou **diátese hemorrágica**.

Para aqueles pacientes identificados como de **alto risco para resistência**, adiciona-se **corticoide** desde o início. Pode ser prednisona ou prednisolona na dose de **1 a 2 miligramas por quilo**, duas vezes ao dia, por dez dias. Depois, reduz-se a dose pela metade e mantém por mais cinco dias.

Algoritmo Prático de Manejo

Quando chega uma criança com suspeita de Kawasaki, primeiro você avalia se ela preenche critérios para Kawasaki completa. Se não preencher, investiga Kawasaki incompleta com os exames laboratoriais e ecocardiograma. Confirmado o diagnóstico, seja completo ou incompleto, indica-se **imunoglobulina e aspirina para todas as crianças**.

O passo seguinte é avaliar o risco de resistência. Se houver fatores de risco, especialmente **menores de 12 meses e principalmente menores de 6 meses**, acrescenta-se o corticoide desde o início. Se não houver fatores de risco, faz-se o

tratamento padrão e **reavalia após 36 horas**. Se a febre persistir acima de 38 graus, configura-se **resistência à imunoglobulina** e indica-se corticoide.

Refratariedade ao Tratamento: O que fazer?

Quando há refratariedade à imunoglobulina e o paciente não recebeu corticoide inicialmente, faz-se a **corticoterapia**. Para pacientes com **aneurisma grande acima de Z score 10** ou com aneurismas em progressão, o tratamento combinado é com **segunda dose de imunoglobulina** associada a **corticoide** ou **infiximabe**, que é um anticorpo anti-TNF.

Se houver falha dessa primeira tentativa de resgate, consideram-se **imunossupressores** como **ciclosporina** ou **ciclofosfamida**.

Seguimento e Cuidados Pós-Tratamento

Toda criança que teve Kawasaki precisa de **seguimento cardiológico** em 7 a 14 dias após o tratamento, ou antes, dependendo da extensão da dilatação coronariana identificada. As **vacinas de vírus vivo atenuado** devem ser adiadas por **11 meses** após o uso de imunoglobulina, a não ser que haja situação de surto ou risco epidemiológico importante.

Um ponto crucial: crianças **maiores de 12 meses** que estejam em uso de **aspirina em dose alta ou moderada** devem receber as vacinas para **varicela e influenza** por causa do risco de **Síndrome de Reye**.

Complicações: O Grande Temor da Kawasaki

A principal complicação e o motivo de toda essa preocupação é a **dilatação e formação de aneurismas coronarianos**. Dependendo da extensão, pode haver necessidade de anticoagulação. Em casos extremos, algumas crianças podem evoluir com **infarto agudo do miocárdio**. O risco é maior nos **dois a três meses após o diagnóstico**, mas vai declinando progressivamente. Contudo, para pacientes que desenvolveram aneurismas permanentes, o risco cardiovascular **persiste para o resto da vida**.

Pontos-Chave para Memorizar

A Doença de Kawasaki é uma vasculite imunomediada de vasos de médio calibre. Os critérios diagnósticos de forma completa exigem febre por pelo menos quatro dias mais quatro ou cinco critérios clínicos. Para Kawasaki incompleta, é necessário associar os achados laboratoriais e o ecocardiograma. O manejo padrão é feito com **imunoglobulina 2 gramas por quilo** em dose única e **AAS em doses altas**, reduzindo após a resolução da febre. Pacientes com risco de resistência recebem **corticoide desde o início**. A principal complicação e maior preocupação são os **aneurismas de coronárias**, que justificam todo o esforço diagnóstico e terapêutico precoce.

As provas mais recentes estão cobrando esse tema de forma cada vez mais aprofundada, inclusive questionando o manejo de pacientes refratários e de alto risco, então dominar esses conceitos é fundamental para sua aprovação.